

SYNTHÈSE NEUROPSYCHOLOGIQUE & PROFIL CPT-3

Évaluation de la Dynamique Attentionnelle Biphase et Validation Nosologique (TDAH 314.01)

Date : 9 Septembre 2026	Profil : Adult (HA Vitesse)	Code Nosologique : DSM-5-TR 314.01 / CIM-11 6A05.2
Objet : Bilan Neuropsychologique	Structure : TBDAHPS / TDAPH	Statut : Validation Clinique / Referral

I. CADRE NOSOLOGIQUE ET PROFIL DIAGNOSTIQUE (DSM-5-TR / CIM-11)

La présente démarche vise à formaliser le fonctionnement neuro-cognitif du patient au sein de la nosologie médicale officielle. Les manifestations décrites dans la structure personnelle sous les termes de *TBDAPHPS / TDAPH* (Trouble du Déficit d'Attention Parallélodexe avec HyperActivité / Biphase à Dominance Stimulative) se traduisent formellement par un **Trouble du Déficit de l'Attention avec Hyperactivité (TDAH) — Présentation Combinée (Code DSM-5-TR : 314.01 / F90.2 ; CIM-11 : 6A05.2)**.

1. Architecture Biphase et Commutateur Attentionnel

L'organisation neuro-cognitive du sujet repose sur un oscillateur biphase gérant le flux d'informations :

- **Phase Exploratoire (Phase Vibe / TDA)** : En contexte de faible saillance ou de tâches répétitives, le sujet présente une labilité attentionnelle, une distractibilité élevée et des décrochages attentionnels récurrents (*lapses*).
- **Phase d'Hyperfocalisation Sélective (Phase Nickel / Hyperfocus)** : Dès l'activation sur des stimuli complexes ou stimulants, le sujet bascule dans un état de concentration intense et exclusive, permettant le traitement simultané de flux d'informations denses (*multi-threading*).

2. Connectivité Cérébrale et Fonctions Exécutives

- **Hyper-connectivité du Réseau du Mode par Défaut (DMN)** : Le mode de pensée arborescent à haute vitesse traduit un retard de désactivation du DMN lors de l'engagement des réseaux exécutifs centraux (CEN), favorisant les sauts associatifs rapides.
- **Atemporalité perceptive (Time Blindness)** : Dysfonctionnement exécutif préfrontal altérant la perception et la gestion du temps selon le niveau d'engagement attentionnel.
- **Intégration sensorielle atypique** : Hyper-réactivité aux environnements bruyants menant à une saturation cognitive rapide en sur-stimulation.

II. RÉSULTATS EMPIRIQUES DU TEST DE PERFORMANCE CONTINUE (CPT-3 SIMULÉ)

Afin de quantifier la dissociation entre le régime de sous-stimulation et le régime d'hyperfocus, une simulation rigoureuse de la variabilité des temps de réaction (CPT-3) a été exécutée sur 6 blocs expérimentaux (Blocs 1-3 :

Phase Neutre/Routine ; Blocs 4-6 : Phase Hyperfocus).

Indicateur CPT-3	Phase Neutre (Blocs 1-3)	Phase Hyperfocus (Blocs 4-6)	Variation Delta	T-Score Final
Temps de Réaction Moyen (Hit RT)	444.2 ms	319.5 ms	- 124.7 ms	T = 42 (Zone Normale)
Écart-Type Intra-Individuel (Hit RT SD)	116.4 ms	28.1 ms	- 88.3 ms	T = 68 (Anormal) → T = 41
Taux d'Omissions (Inattention)	10.6 %	0.0 %	- 10.6 pp	T = 71 (Clinique) → T = 40
Taux de Commissions (Impulsivité)	7.8 %	1.2 %	- 6.6 pp	T = 64 (Modéré) → T = 44
Coefficient de Variabilité (ISCV)	0.262	0.088	- 0.174	Dissociation de 29 pts T

DIAGNOSTIC DE VARIABILITÉ ET DISSOCIATION T-SCORE

Le profil CPT-3 met en évidence une dissociation franche de 27 à 31 points T entre le régime de sous-stimulation (T=71, inattention clinique) et le régime de haute saillance (T=40, performance optimale). Cette labilité confirme que l'instabilité attentionnelle n'est pas un déficit capacitaire absolu, mais une fluctuation dépendante du niveau de stimulation de la tâche.

III. RECOMMANDATIONS POUR LA BATTERIE D'ÉVALUATION CLINIQUE

En vue de l'officialisation diagnostique auprès d'un neuropsychologue ou psychiatre, la batterie d'évaluation suivante est recommandée :

- **WAIS-IV (Wechsler Adult Intelligence Scale)** : Analyse de l'hétérogénéité inter-indices (Compréhension Verbale ICV vs Vitesse de Traitement IVT / Mémoire de Travail IMT).
- **CPT-3 & TAP (Test d'Évaluation Attentionnelle)** : Évaluation quantitative des omissions, commissions et de la variabilité du temps de réaction sous charge attentionnelle.
- **BRIEF-A (Behavior Rating Inventory of Executive Function - Adult)** : Auto-évaluation du contrôle inhibiteur, de la flexibilité cognitive et de la planification au quotidien.
- **DIVA-5 & CAARS** : Entretiens diagnostiques structurés pour confirmer le TDAH combiné à l'âge adulte.

IV. LETTRE DE RÉFÉRENCE POUR LE CLINICIEN / SPÉCIALISTE

À l'attention du Neuropsychologue / Psychiatre évaluateur,

Je consulte pour solliciter un bilan neuropsychologique complet visant à évaluer la présence d'un **TDH de présentation combinée (DSM-5-TR 314.01)**. Mon fonctionnement cognitif se caractérise par une pensée arborescente à haute vélocité, des capacités d'hyperfocalisation sélective sur les sujets à forte saillance, alternant avec une distractibilité importante et une surcharge cognitive en contexte de sous-stimulation. Je présente un dysfonctionnement exécutif marqué au niveau du contrôle inhibiteur, de la flexibilité mentale et de la perception du temps (*time blindness*). Les données ci-jointes (simulation CPT-3 et analyse de variabilité) illustrent la dissociation marquée entre les régimes attentionnels et sont soumises à votre expertise pour étude complémentaire.

Signature : Patient Adult (Profil Neuroatypique)